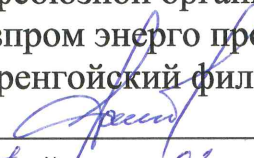


**ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

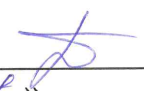
СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации
«Газпром энерго профсоюз
— Уренгойский филиал»

 Е.А. Нагайцева
« 28 » 02 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

 Д.Б. Цапко
« 28 » 02 2025 г.

ИНСТРУЦИЯ

**по оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве**

г. Новый Уренгой, 2025

Тематический план

Введение:

1. Ознакомление с правовой базой. Основной порядок действий в критической ситуации. Общая оценка ситуации. Соблюдение правил личной безопасности. Оценка состояния пострадавшего. Вызов экстренных служб.
2. Базовые реанимационные мероприятия.
3. Инородные тела ВДП. Методы восстановления проходимости. Механическая асфиксия. Утопление, виды утоплений. Первая помощь.
4. Травмы (ушибы, растяжения, вывихи, переломы). Первая помощь при травмах. Правила иммобилизации и транспортировки. Синдром длительного сдавления.
5. Виды ран. Обработка ран. Проникающие ранения. Кровотечения. Их виды. Первая помощь при кровотечениях. Методы остановки кровотечений. Внутренние кровотечения. Понятие шока. Первая помощь.
6. Первая помощь при термических поражениях (гипер- и гипотермические воздействия локальные и местные). Химические ожоги.
7. Острые отравления, их виды. Первая помощь при различных видах отравлений.
8. Поражение электрическим током. Методы подхода, освобождения от фактора воздействия. Эвакуация из очага поражения, правила собственной безопасности. Первая помощь.
9. Правила перемещения, эвакуации пострадавшего, ухода за пострадавшим или больным до приезда бригады скорой помощи. Аптечка первой помощи.

Первая помощь

Первая помощь (далее - ПП) представляет собой комплекс простейших мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых до прибытия медицинских работников

Основными задачами ПП являются:

- а) Проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни пострадавшего
- б) Вызов скорой помощи
- в) Предупреждение возможных осложнений
- г) Обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки пострадавшего

Цели первой помощи

- 1. Спасти человеку жизнь
- 2. Препятствовать дальнейшему ухудшению состояния
- 3. Обеспечить профилактику осложнений и возможность дальнейшего оказания помощи

Правовые аспекты оказания первой помощи

1. Конституция РФ

Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь

2. Закон «Об охране здоровья граждан» 21 ноября 2011 г. N 323

Статья 18. Право на охрану здоровья

Статья 19. Право на медицинскую помощь

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.

Статья 29. Организация охраны здоровья.

Организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями.

Статья 31. Первая помощь (Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб).

3. Трудовой кодекс РФ

Статья 214. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

Обязан обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим;

Обязан обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.

Статья 215. Работник в области охраны труда обязан проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда.

Статья 216.3 Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание.

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Статья 219. Обучение по охране труда

Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодателями - индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в ходе проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

4. Стандарты ГОСТ 12.0.230-2007 «Система управления охраной труда».

5. Уголовный кодекс РФ N 63-ФЗ от 13.06.1996, с изменениями от 07.04.2015г.

Статья 39. Крайняя необходимость (Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости).

Статья 124. Неоказание помощи больному (Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев; То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

Статья 125. Оставление в опасности (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года).

6. ЕСУПБ ПАО «Газпром» (Единая Система Управления Производственной Безопасностью)

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

п. 32. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.05.2024 №220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи»

Кто оказывает помощь - лица, обязывающие оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющие специальную подготовку, в том числе сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, пожарные, а также водители транспортных средств и другие лица при наличии соответствующей подготовки.

Первая помощь может оказываться непосредственно на месте происшествия, в безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия, а также во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию.

Первая помощь оказывается при условии отсутствия угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица.

Оказание первой помощи допускается, если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи.

При оказании первой помощи используются укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и

(или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и (или) остановка кровообращения.
3. Нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания.
4. Наружные кровотечения.
5. Травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.
6. Отравления.
7. Укусы или ужаления ядовитых животных.
8. Судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания.
9. Острые психологические реакции на стресс.

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения

1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи:

определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;

устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);

обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);

оценка количества пострадавших;

устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;

устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;

извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке

инородным телом;

перемещение пострадавшего в безопасное место.

Оценка состояния

Оценка
места

- Безопасность места происшествия (собственная безопасность, присутствующих, пострадавшего).
- Каков механизм травмы или заболевания?

Начальная оценка состояния
пострадавшего

- В любой ситуации, когда она представляется Вам критической, а состояние пострадавшего - тяжёлым, необходимо срочно оценить и в дальнейшем держать под контролем 5 параметров: **Безопасность, Сознание, Дыхание, Пульс, Движения**.

Оценка наличия
сознания

- Окрикнуть пострадавшего, встряхнуть, взявшись за плечи и громко спросить: «Что с Вами? Помогите, пожалуйста!»

Оценка наличия
сознания





Вызов Скорой Помощи

Соберите нужную информацию до звонка в «103» или «03», «112». Этим вы ускорите время вызова Скорой Помощи

Если спасатель один и чтобы вызвать скорую нужно оставить пострадавшего, то:

а) Если пострадавший в сознании предупредить его что ненадолго уходите

б) Если в сознании, но с кровотечением - сначала остановить кровотечение, потом уходить за помощью

с) Если без сознания, но дышит - восстановительное положение

д) Если не дышит предпочтительно вызвать сначала 03 (всё зависит от доступности скорой)

е) Если не дышит в результате травмы, утопления, обструкции дыхательных путей, отравления наркотиками или алкоголем, если это ребёнок, то необходимо провести СЛР в течение минуты, прежде чем вызвать 03.

Пол.

Количество пострадавших.

Возраст. Примерно, подросток, около 30 и т. п.

Что случилось. Кратко, ДТП, без сознания и т. п.

Адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, номер квартиры, код подъезда или домофон (этим вы ускорите прибытие бригады к пострадавшему). Точный адрес, с ориентирами, как можно проехать, если машина не сможет подъехать к самому месту ЧС, то где и кто будет встречать.

Если трудно найти, то где вы их встречаете. Обязательно послать человека встречать специалистов.

Кто вызвал — прохожий, родственник сосед и т. п.

Оставьте свой номер телефона. У бригады могут быть уточнения по мере выдвижения к вам. Это особенно важно, если вы где-нибудь на автостраде или в месте, вам незнакомом.

Трубку вешаем только после того, как повесит диспетчер.

Первичная (Базовая) сердечно-лёгочная реанимация

Алгоритм Базовой реанимации

1. Убедиться в безопасности для себя, пострадавшего и окружающих; устранить возможные риски.



2. Проверить реакцию пострадавшего: аккуратно встряхнуть его за плечи и громко спросить “Что с Вами?”. Не следует тратить время на проверку пульса на сонной (или другой) артерии – это недостоверный метод.

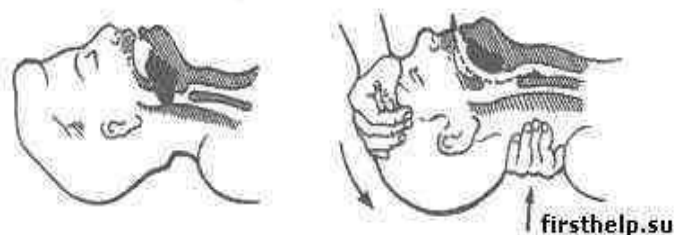


3. Принять решение:

если пострадавший реагирует – оставить его в том же положении, попытаться выяснить причины происходящего и позвать на помощь, регулярно оценивать состояние пострадавшего;

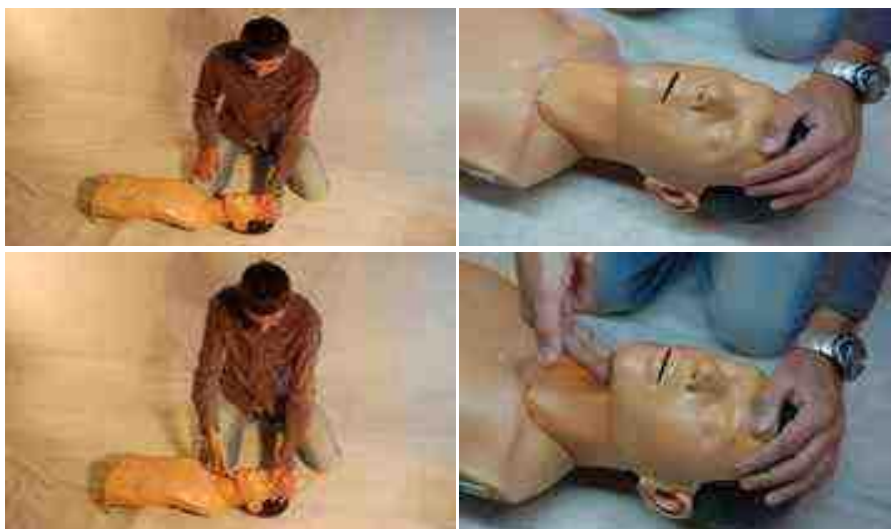


если пострадавший не реагирует – громко позвать на помощь, повернуть на спину и открыть дыхательные пути.



Открыть дыхательные пути путем запрокидывания головы и подтягивания подбородка – рукой нужно надавить на лоб, а другой рукой подтянуть подбородок.

Альтернативный способ – запрокидывание головы путем подведения одной руки под шею больного, а другой – на лоб пострадавшего.



4. После открытия дыхательных путей надо проверить дыхание. Поддерживая дыхательные пути открытыми необходимо увидеть, услышать и почувствовать дыхание, наблюдая за движениями грудной клетки, прислушиваясь к шуму дыхания и ощущая движение воздуха на своей щеке. Исследование продолжать не более 10 сек.



При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего следует организовать вызов скорой медицинской помощи, привлекая помощника.



Принять решение:

дыхание нормальное, ненормальное или отсутствует.

Необходимо помнить о том, что у 40% пострадавших в первые минуты после остановки кровообращения может развиваться агональное дыхание (редкие, короткие, глубокие судорожные дыхательные движения) или другие патологические типы дыхания. Агональное дыхание может возникнуть во время проведения компрессий грудной клетки как признак улучшения перфузии головного мозга, но не признак восстановления спонтанного кровообращения. Если возникают сомнения в характере дыхания – вести себя так, как будто дыхание патологическое. Таким образом, отсутствие сознания и дыхания (или патологическое дыхание) – признаки остановки кровообращения и показания к началу СЛР.

5. Принять решение:

А) если пострадавший дышит нормально – поместить его в боковое стабильное положение, вызвать скорую помощь, регулярно оценивать состояние и наличие нормального дыхания;



Б) если у пострадавшего патологический тип дыхания или оно отсутствует – попросить окружающих вызвать помощь и начать СЛР



firsthelp.su



СЛР начинается с компрессии грудной клетки:

1. встать на колени сбоку от пострадавшего;
расположить основание одной ладони на центре грудной клетки пострадавшего (т.е. на нижнюю половину грудины);
2. расположить основание другой ладони поверх первой ладони;
3. сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться, что вы не оказываете давление на ребра; выгнуть руки в локтевых суставах; не оказывать давление на верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины;
4. расположить корпус тела вертикально над грудной клеткой пострадавшего и надавить на глубину как минимум на 5 см, но не более 6 см;



5. обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери контакта рук с грудиной после каждой компрессии;
6. продолжать компрессии грудной клетки с частотой от 100 до 120/мин;
7. компрессии и декомпрессии грудной клетки должны занимать равное время;
8. компрессии грудной клетки следует проводить только на жесткой поверхности. Необходимо выполнять декомпрессию противопролежневых матрасов перед началом СЛР, используя специальный экстренный клапан;

9. при выполнении БРМ в ограниченных по площади пространствах, компрессии возможно выполнять через голову пострадавшего или, при наличии двух спасателей, стоя над пострадавшим с расставленными ногами.



10. Компрессии грудной клетки необходимо сочетать с искусственными вдохами (“изо рта в рот”, “изо рта в нос”, “изо рта в трахеостому”):

11. после 30 компрессий открыть дыхательные пути, как было описано выше;

12. зажать крылья носа большим и указательным пальцами руки, расположенной на лбу;

13. открыть рот, подтягивая подбородок;

14. сделать нормальный вдох и плотно охватить своими губами рот пострадавшего;

15. произвести равномерный вдох в течение 1 сек, наблюдая при этом за подъемом грудной клетки, что соответствует дыхательному объему около 500-600 мл (признак эффективного вдоха); избегать форсированных выдохов;

16. поддерживая дыхательные пути открытыми, приподнять свою голову и наблюдать за тем, как грудная клетка опускается на выдохе;

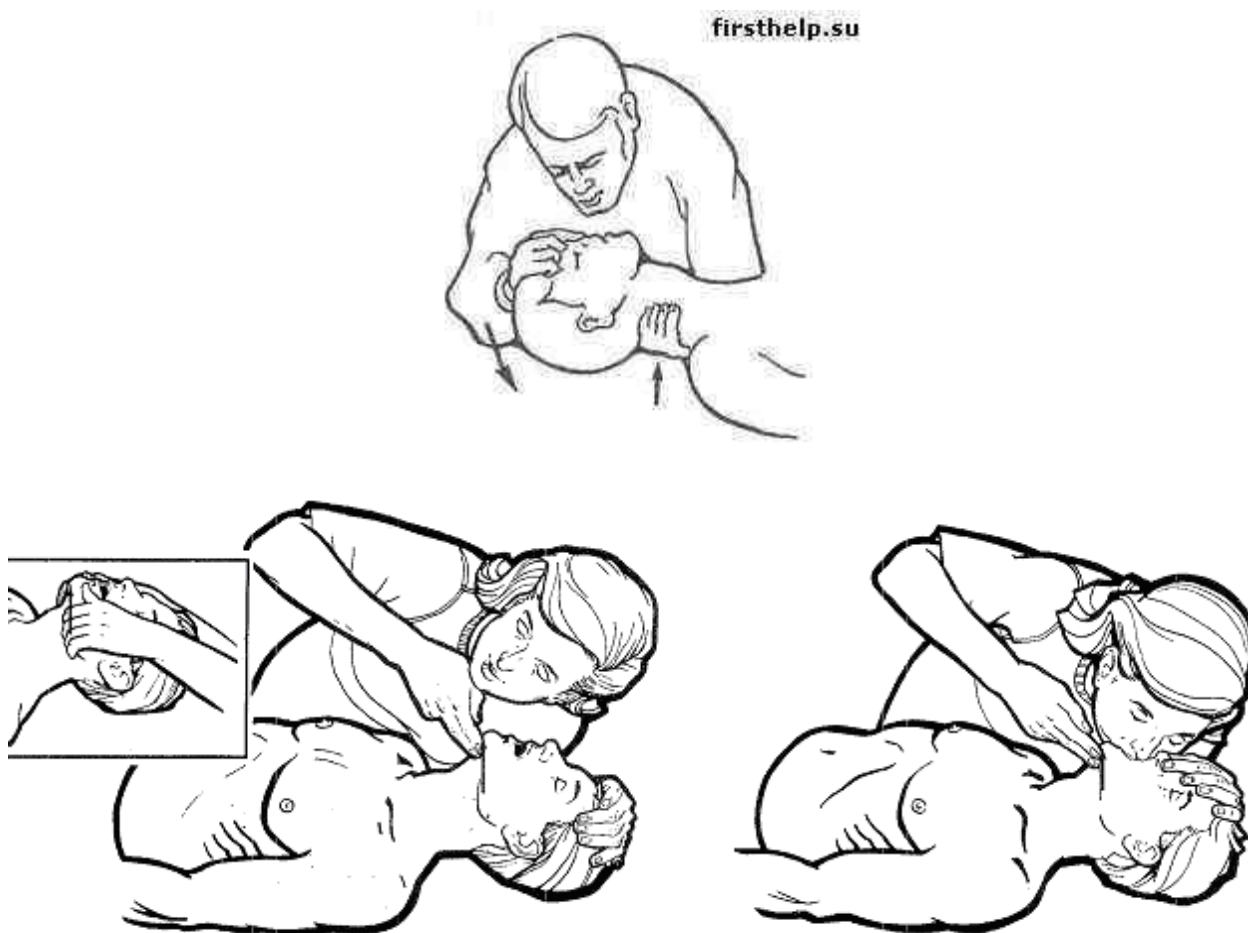


возможная альтернатива проведения БРМ для лиц без медицинского образования – выполнение только непрерывных, качественных компрессий грудной клетки с частотой 100-120/мин. Тем не менее, полноценные БРМ (компрессии+дыхание) предпочтительны. БРМ без искусственного дыхания неприемлемы при гипоксической ОК (утопление, обструкция дыхательных путей инородным телом и др.)



17. Принять решение: если первый искусственный вдох оказался неэффективным, перед следующим вдохом необходимо удалить инородные тела изо рта пострадавшего, проверить адекватность открывания дыхательных путей. Не следует делать более 2-х попыток искусственных вдохов;

18. сделать еще один искусственный вдох. Всего необходимо сделать 2 искусственных вдоха, которые должны занять не более 5 сек. Следует избегать гипервентиляции, которая ухудшает венозный возврат к сердцу.



19. После этого сделать 30 компрессий грудной клетки и далее продолжать СЛР в соотношении компрессии: вентиляции 30:2. Компрессии грудной клетки должны выполняться с минимальными перерывами.

20. Реанимационные мероприятия прекращают только при признании их абсолютно бесперспективными или констатации биологической смерти, а именно:

а) при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса мероприятий, направленных на поддержание жизни;

б) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций в течение 30 мин.

с) При чрезмерной усталости спасателя

Реанимационные мероприятия не проводятся:

а) при наличии признаков биологической смерти;

б) при наступлении состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний.

СЛР двумя спасателями:

один спасатель выполняет компрессии грудной клетки, другой – искусственную вентиляцию. Спасатель, выполняющий компрессии грудной клетки, громко считает количество компрессий и отдает команду второму спасателю на выполнение 2-х вдохов. Спасатели меняются местами каждые 2 мин.

Инородные тела ВДП. Методы восстановления проходимости.

Механическая асфиксия. Утопление, виды утоплений. Первая помощь.

Инородные тела верхних дыхательных путей.

Причины: попадание инородных тел в верхние дыхательные пути.

В соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и Национального совета по реанимации России, выделяют закупорки верхних дыхательных путей инородным телом умеренной и тяжелой степени:

Признаки	Тяжесть состояния	
	Закупорка умеренной степени	Закупорка тяжелой степени
Реакция на вопросы	Отвечает на вопрос «Ты поперхнулся» словами	Не может говорить, может кивать

Другие признаки	Может кашлять, дышать	Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), может хватать себя за горло
------------------------	-----------------------	--

При закупорке умеренной степени предложите пострадавшему покашлять. Более ничего не предпринимайте!



При закупорке тяжёлой степени предпринять меры по удалению инородного тела. Для этого необходимо сделать следующее

1. Встаньте сбоку и немного сзади пострадавшего.
2. Придерживая грудную клетку пациента одной рукой, другой наклоните его вперёд, чтобы в случае смещения инородного тела оно попало в рот пострадавшего, а не опустилось ниже в дыхательные пути
3. Нанесите 5 резких ударов между лопатками основанием ладони.
4. Проверяйте после каждого удара, не удалось ли устранить обструкцию.



Если после 5 ударов обструкция не устранена - сделайте 5 попыток надавливания на живот следующим образом (метод или прием Геймлиха)

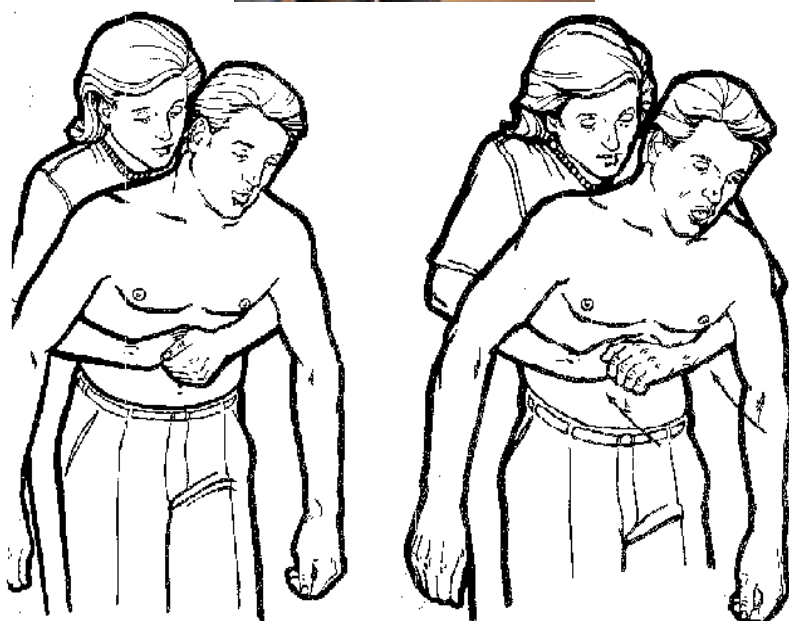
1. Встаньте позади пострадавшего, обхватите его сзади обеими руками на уровне верхней половины живота.
2. Наклоните пострадавшего вперед.



3. Сожмите руку в кулак, поместите его посередине между пупком и мечевидным отростком грудины



4. Повторите этот метод при необходимости до 5 раз.



Если удалить инородное тело не удалось, продолжайте попытки его удаления, перемежая удары по спине с приёмом **Геймлиха** по 5 раз.

Если пострадавший потерял сознание – начните сердечно-лёгочную реанимацию в объеме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких.

Утопление

Полное прекращение поступления воздуха в лёгкие называется асфиксией.

Утопление – это асфиксия в результате наполнения дыхательных путей водой или другой жидкостью.

При утоплении у пострадавшего вначале кратковременно задерживается дыхание, затем он теряет сознание, дыхательные пути заполняются водой, в результате чего наступает резкое нарушение дыхания и его остановка. В результате к мозгу перестаёт подходить кислород, он погибает и наступает смерть.

Виды утоплений:

Сухое утопление - возникает в результате рефлекторного спазма гортани при попадании воды на голосовые связки. Наступает удушье, пострадавший теряет сознание и опускается на дно. У таких больных кожа бледная с синеватым оттенком

Истинное утопление – вода попадает в лёгкие и закупоривает их. Кожа синюшного цвета, изо рта выделяется пенистая жидкость. Набухшие вены шеи и плеча.

Синкопальное утопление (белая смерть) – возникает в результате внезапной остановки дыхания и кровообращения. Кожа бледная.

Есть различия и при утоплении в пресной и солёной воде:

Пресная вода, попадая в лёгкие, быстро всасывается в кровь и вызывает там гемолиз (разрушение клеток крови).

Солёная вода, попадая в лёгкие, не всасывается в кровь, а наоборот, вызывает приток жидкости из крови в лёгкие.

При утоплении следует выполнять мероприятия, в зависимости от состояния БСДК:

1. Если пострадавший без сознания, необходимо сразу начать СЛР, не тратя время на сливание воды изо рта пострадавшего.

2. Если пострадавший находится в сознании, достаточно уложить его на сухую жесткую поверхность, затем раздеть, растереть руками или сухим полотенцем. Дать горячее питье (чай, кофе), укутать теплым одеялом

Травмы (ушибы, растяжения, вывихи, переломы). Первая помощь при травмах. Правила иммобилизации и транспортировки. Синдром длительного сдавления.

Травмы и их проявления:

Ушибы мягких тканей - проявляются болью, усиливающейся при надавливании, отечностью и кровоподтёком в месте повреждения.

Растяжения и разрывы связок, сухожилий и мышц - проявляется внезапной болью в суставе, к которому относится связка, мышца или сухожилие. Боль, усиливающаяся при ощупывании и движениях. Отечность и кровоподтёки и утрата работоспособности в травмированной конечности

Вывихи и переломы:

Вывих – это смещение суставной поверхности кости из суставной сумки. Наиболее подвержены вывихам плечо, но часто встречаются вывихи пальцев, локтя, нижней челюсти, бедра, голени.

Проявляется изменением формы конечности в области сустава, опухолью, кровоподтёком, болью и болезненностью при прикосновении, невозможностью движений в конечности (заклинивание сустава).

Переломы – это повреждения костей, которые сопровождаются нарушением ее целостности. При переломах одновременно с повреждением кости нарушается целостность окружающих мягких тканей, могут травмироваться расположенные рядом мышцы, сосуды, нервы и т.д.

При сопутствующем перелому повреждению кожи и наличии раны перелом называют открытым, а если кожа цела – закрытым

Травмы – первая помощь

Ушибы мягких тканей - первая помощь:

1. Покой повреждённой конечности
2. Уложить конечность так, чтобы повреждённое место было выше уровня сердца
3. Как можно быстрее приложить к повреждённому месту пакет со льдом или холодный предмет (резиновый пузырь со льдом или холодной водой и т.п.) через ткань или пластик. Но не более чем на 20 минут, каждые 2-3 часа.
4. Медицинская помощь чаще не требуется



Растяжения и разрывы связок, сухожилий и мышц - первая помощь:

1. Покой повреждённой конечности
2. Уложить конечность так, чтобы повреждённое место было выше уровня сердца
3. Как можно быстрее приложить к повреждённому месту пакет со льдом или холодный предмет (резиновый пузырь со льдом или холодной водой и т.п.) через ткань или пластик. Но не более чем на 20 минут, каждые 2-3 часа.
4. Наложить на повреждённый участок конечности тугую повязку, желательно эластичный бинт. Ее снимать на время прикладывания льда.
5. Отправить пострадавшего в медицинское учреждение.



Вывихи и переломы:

При переломах основной задачей первой помощи является обеспечение спокойного и наиболее удобного положения для поврежденной конечности, что достигается полной ее неподвижностью.

Для иммобилизации используются готовые шины, а также палка, доска, линейка, кусок фанеры и т.п.

Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, особенно с переломами, даже на короткое расстояние.

При закрытом переломе конечности не следует снимать с пострадавшего одежду - шины нужно накладывать поверх нее.

При наличии раны, например, в случаях открытого перелома конечности, одежду лучше разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала хорошо доступна). Затем на рану накладывают стерильную повязку и лишь после

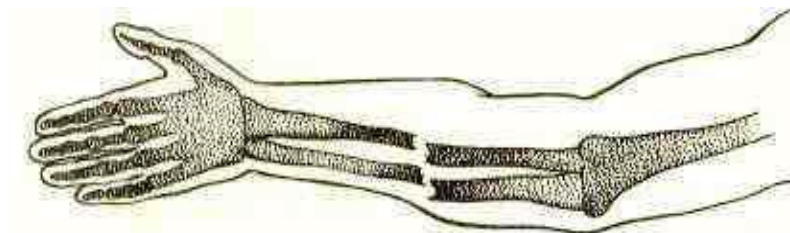
этого осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или бинты не должны сильно давить на раневую поверхность).

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении кровоостанавливающего жгута, его накладывают до шинирования и не прикрывают повязкой. Не следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать конечность для "лучшей" фиксации шины, т.к. это может вызвать нарушение кровообращения или повреждение нервов. В зимнее время или в холодную погоду, особенно при длительной транспортировке, после шинирования поврежденную часть тела тепло укутывают.

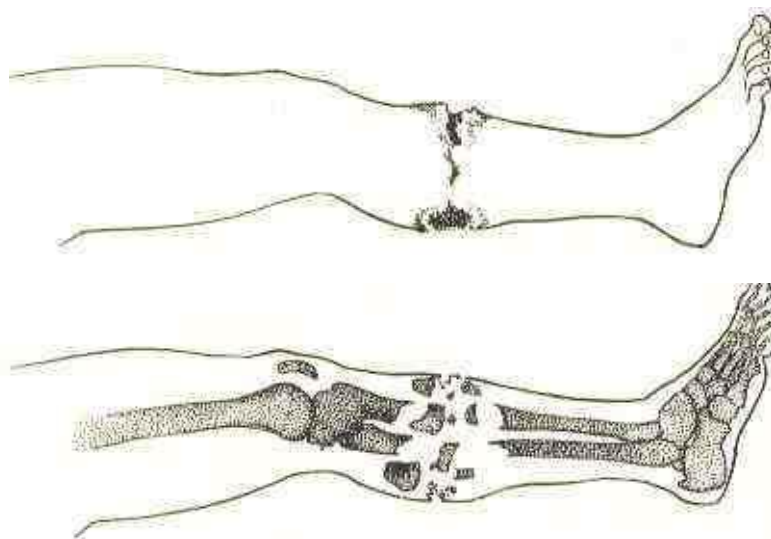
Первая помощь:

1. Часто трудно отличить перелом от вывиха, поэтому нельзя вправлять вывих самостоятельно! Исключение - привычный вывих, в чём пострадавший бывает уверен.
2. При вывихах в крупных суставах, вызвать 03 и контролировать БСДК (безопасность, сознание, дыхание, кровообращение)!
3. Если прибытие скорой ожидается вскоре, накладывать шину не нужно - просто предложить пострадавшему принять удобное для него положение и фиксировать конечность руками.
4. Снять с конечности кольца, браслеты и т.п.
5. Если скорая прибыть не может, накладывается шина. Создать покой повреждённой конечности.
6. Если позволяет характер травмы, уложить конечность так, чтобы повреждённое место было выше уровня сердца.
7. Приложить к месту вывиха пакет со льдом или холодный предмет (резиновый пузырь со льдом или холодной водой и т.п.) через ткань на 20 минут, через каждые 2-3 часа.
8. Транспортировать пострадавшего в больницу.

Переломы



ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ



ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Общие правила иммобилизации:

1. До наложения шины не изменять положение пострадавшего, за исключением внешней угрозы, не пытаться выпрямить конечность путём вытяжения
2. Перед наложением обнажить и осмотреть конечность.
3. Шина должна обездвиживать один сустав выше и не менее одного сустава ниже места повреждения.
4. Если область травмы включает сустав, накладывать шину на конечность, не меняя её положения.
5. После наложения шины рекомендуется проверить пульс и чувствительность ниже места наложения шины и приподнять травмированную конечность.
6. При переломе мелких костей наложить шину и направить пострадавшего в травм пункт.
7. При переломах костей предплечья, плеча и ключицы можно применять косыночную повязку или фиксировать конечность к грудной клетке.
8. Все переломы нижней конечности могут быть иммобилизованы с помощью фиксации повреждённой конечности к противоположной ноге - с прокладкой из одеяла или верхней одежды между ног.

Иммобилизация верхней конечности при повреждении (вывихе) плечевого сустава с помощью косынки: а, б — этапы иммобилизации.



Синдром длительного сдавливания:

При сдавливании в завале, при ДТП, крупных мышечных масс (например, бедра), в сдавленной конечности прекращается кровообращение, и через определённое время в её тканях накапливается большое количество продуктов нарушения жизнедеятельности мышц (миоглобин, калий). При освобождении сдавливающей силы эти продукты быстро поступают в кровоток, часто приводя к тяжёлым последствиям.

Признаки:

- Сдавление более 60 минут
- Вовлечение больших мышечных масс
- Отсутствие пульса в сдавленной конечности
- Кожные покровы бледные, холодные, влажные
- Слабый, частый пульс
- Часто отсутствие болей в поражённой конечности
- Начальные симптомы шока

Первая помощь

1. Вызвать «103» или «03», «112»
2. Произвести начальную оценку пострадавшего. В любой ситуации, когда она представляется Вам критической, а состояние пострадавшего - тяжёлым, необходимо срочно оценить и в дальнейшем держать под контролем 5 параметров: **Безопасность, Сознание, Дыхательные пути, Дыхание, Кровообращение (БСДДК).** А при кровотечении есть или нет шок, вид кровотечения.
3. Контроль БСДДК
4. В ожидании бригады скорой помощи необходимо успокоить пострадавшего, обеспечить ему покой, а при необходимости - согреть.
5. При необходимости СЛР.

Если сдавление продолжается менее 1 часа.

6. освободить из завала или транспортного средства (если это безопасно).

7. Наложить холод на повреждённую конечность.

Если сдавление продолжается более 1 часа

8. Перед извлечением на конечность наложить жгут по всем правилам наложения жгута.

9. Освободить пострадавшего, и после извлечения начиная с кончиков пальцев и до жгута накладывается давящая повязка.

10. После наложения повязки жгут снимается.

Жгут оставляют в случае

А) артериальное кровотечение из повреждённой конечности

Б) трупное окоченение конечности (невозможность пассивного её сгибания)

Оказать первую помощь по поводу других повреждений до прибытия бригады скорой помощи

Ничего не давать пострадавшему через рот!

Зафиксировать конечность шиной или подручными средствами, придать по возможности конечности возвышенное положение и транспортировать своими силами.

Наложить холод на повреждённую конечность

Виды ран. Обработка ран. Проникающие ранения. Кровотечения.

Их виды. Первая помощь при кровотечениях. Методы остановки кровотечений. Внутренние кровотечения. Понятие шока. Первая помощь.

Виды ран:

Рана – это повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, сопровождающиеся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек.

В зависимости от формы ранящего предмета или вида оружия раны разделяют

Резаные раны наносят предметами или холодным оружием, имеющими острые края, (нож, стекло, лезвие бритвы). Такие раны имеют ровные края, обычно зияют и сильно кровоточат. Боль при резаных ранах выражена в меньшей степени, чем при других видах ранений.

Рубленые раны наносятся топором. По своему они схожи с резанными, но более глубокие и иногда сопровождаются повреждением костей.

Колотые раны наносятся колющими предметами - иглой, гвоздем, штыком, ножом и др. Для них характерно небольшое раневое отверстие в коже, но ткани при этом повреждаются обычно довольно глубоко, иногда

повреждаются и внутренние органы человека. Наружное кровотечение обычно незначительно.

Рваные раны возникают при ранениях осколками снарядов, при попадании человека под колеса движущегося транспорта и т.д. У рваных ран края неровные, окружающие ткани сильно повреждены. Кровотечение небольшое, болевые ощущения всегда значительные.

Ушибленные раны по внешнему виду похожи на рваные. Ушибленные раны возникают при сильном ударе камнем или другим тупым предметом, при обвалах, воздействии ударной волны.

Если рваные или ушибленные раны сопровождаются обширным повреждением тканей, их называют **размозженными**.

Рваные, ушибленные и размозженные раны часто сопровождаются развитием раневой инфекции.

Укушенные раны причиняются зубами животных и человека. В укушенные ранения обычно попадает инфекция, всегда содержащаяся в ротовой полости. Они часто нагнаиваются и плохо заживают.

Огнестрельные раны наносятся пулями, осколками снарядов, дробью. Раны, нанесенные огнестрельным оружием, бывают рваные, ушибленные или размозженные. При огнестрельных ранениях сильно повреждаются ткани, нередко пуля или осколок, попадая в кости скелета, дробит их на части, а костные осколки дополнительно повреждают мягкие ткани.

При различных ранениях и повреждениях в рану попадают микробы вместе с ранящим предметом, кусками одежды, дерева, комьями земли и пр., из воздуха, а также при прикосновении к ране руками, на которых микробы всегда имеются в большом количестве.

Раны, зараженные микробами, называют **инфицированными**, а возникающее вследствие этого заболевание - **раневой инфекцией**.

Инфицированная рана через несколько часов или дней покрывается налетом, края ее становятся отечными, окружающая кожа краснеет, боли в ране, обычно стихающие через несколько часов после ранения, возобновляются. Повышается температура тела, и самочувствие пострадавшего ухудшается.

Обработка ран:

1. Обнажить рану не загрязняя ее и не причиняя боли.
2. Верхнюю одежду снимают или разрезают (распарывают по шву). При ранениях конечностей надо снять одежду сначала со здоровой конечности, а затем с поврежденной.
3. Зимой, чтобы избежать охлаждения раненого, разрез лучше делать в виде клапана (два горизонтальных разреза - выше и ниже раны - и один вертикальный), получившийся клапан откладывают при перевязке в сторону.

4. После обнажения раны ее быстро осматривают. При этом нельзя трогать рану руками, очищая ее от загрязнения, смазывать или промывать какими - либо растворами, удалять находившиеся в ней осколки костей, куски приставшей к ране одежды и т.п. Нельзя вправлять выпавшие внутренние органы, использовать для перевязки нестерильный материал.

5. Кожу вокруг раны смазывают настойкой йода.

6. После наложения повязки, при необходимости, одежду надевают в обратном порядке, т.е. сначала на больную конечность, а затем на здоровую, клапаном из одежды прикрывают повязку и закрепляют сверху бинтом.

7. Для повязок применяется индивидуальный перевязочный пакет, а при отсутствии — марлевые салфетки или бинты, вата.

8. Бинтовать в наиболее удобном для пострадавшего положении, наблюдая за его лицом.

9. Бинт обычно держат в правой руке, а левой удерживают повязку и расправляют бинт. Бинт ведут слева направо и раскатывают, не отрывая от поверхности тела. Каждый последующий ход бинта должен прикрывать предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины.

10. Бинтовать руку при согнутом под небольшим углом локтевом суставе, а ногу - при согнутом под небольшим углом коленном суставе. Бинтовать конечности начинают с периферии и ходы бинта ведут по направлению к корню конечности. Неповрежденные кончики пальцев нужно оставлять открытыми, чтобы можно было по ним следить за кровообращением.

11. При наложении повязки и по окончании бинтования проверяют, не туго ли лежит повязка, не слишком ли она свободна, не будет ли сползать и разматываться.



Кровотечение:

Кровотечение – это истечение крови из кровеносных сосудов при повреждении или нарушении проницаемости их стенки. Потеря крови представляет непосредственную угрозу для жизни пострадавшего и от незамедлительных действий оказывающего помощь зависит его судьба.

Но, несмотря на это, необходимо помнить о риске заражения через кровь пострадавшего, поэтому по возможности необходимо предотвратить попадание крови больного на кожу и слизистые. При попадании необходимо промыть под струёй воды.

При возникновении кровотечения в организме начинается ряд реакций, вследствие которых происходит спазм сосудов и начинает образовываться сгусток крови в месте повреждения. При повреждении крупных сосудов образованию сгустка крови может препятствовать давление и скорость крови в них.

При возникновении неконтролируемых кровотечений возникает опасность возникновения шока и может привести к смерти.

По происхождению различают:

- **травматические**, вызванные механическим повреждением сосудистой стенки
- **нетравматические**, связанные с патологией стенки сосудов.

По виду кровоточащего сосуда различают:

- артериальные
- артериовенозные
- венозные
- капиллярные кровотечения.

По месту излития крови различают:

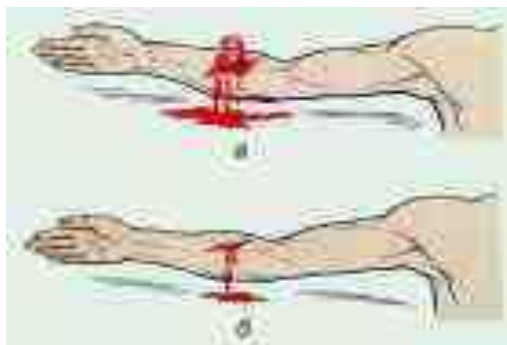
наружные кровотечения — выход крови во внешнюю среду.

внутренние кровотечения- при которых кровь изливается в замкнутую полость тела или в просвет полого органа.

Артериальное кровотечение - характеризуется пульсирующей, ярко-красной кровью, его наиболее трудно остановить из-за высокого давления в сосудах.

Венозное кровотечение - кровь вытекает равномерной струей, имеет тёмно-красный цвет, оно может быть обильным, но его легче остановить.

Капиллярное кровотечение - кровь просачивается в ране, имеет красный цвет, легко остановить



Виды кровотечения:

а – артериальное;

б – венозное

Оказание первой помощи при наружном кровотечении

1. Вызвать «103» или «03», «112»
2. Произвести начальную оценку пострадавшего-В любой ситуации, когда она представляется Вам критической, а состояние пострадавшего - тяжёлым, необходимо срочно оценить и в дальнейшем держать под контролем 5 параметров: Безопасность, Сознание, Дыхательные пути, Дыхание, Кровообращение (БСДДК). А при кровотечении есть или нет шок, вид кровотечения.

3. Контроль БСДДК.

4. В ожидании бригады скорой помощи необходимо успокоить пострадавшего, обеспечить ему покой, а при необходимости - согреть.

Основной метод остановки кровотечения - прямое пальцевое прижатие или давление на рану, лучше через стерильную повязку или салфетку. Продолжать давить в течение 15-20 минут, вплоть до полной остановки кровотечения.



При отсутствии повреждений мышц и костей прямое давление можно дополнить возвышенным положением повреждённой конечности.

При отсутствии эффекта при кровотечениях из больших зияющих ран, может потребоваться прижатие ладонью с помощью ватного тампона.

При неэффективности или если имеются несколько источников кровотечения, применяют тугое бинтование (или давящая повязка) и дополнительное прямое прижатие.

Для наложения давящей повязки используют стерильные салфетки, которые накладывают на рану и бинт соответствующего размера

Бинт наматывают на область ранения с усилием, достаточным для остановки кровотечения, при этом бинт должен свободно раскатываться по конечности



После наложения повязки конец бинта надо разрезать и завязать для закрепления



После остановки кровотечения обработать края раны, закрыть её стерильной салфеткой, туго забинтовать. Придать конечности возвышенное положение (если нет переломов) и приложить к ране лёд на 15-20 минут



МЕСТА И СПОСОБЫ ПРИЖАТИЯ АРТЕРИЙ

- 1 - височной; 2 - наружной челюстной; 3 - сонной; 4 - подключичной;
5 - плечевой; 6 - локтевой; 7 - лучевой; 8 - бедренной; 9 - задней большеберцовой;
10 - тыла стопы; 11 - брюшной аорты

Места прижатия артерий

Сонная артерия прижимается на шее между гортанью и кивательной мышцей к позвоночнику большим пальцем или 4-мя пальцами



Подключичная артерия прижимается к 1-му ребру



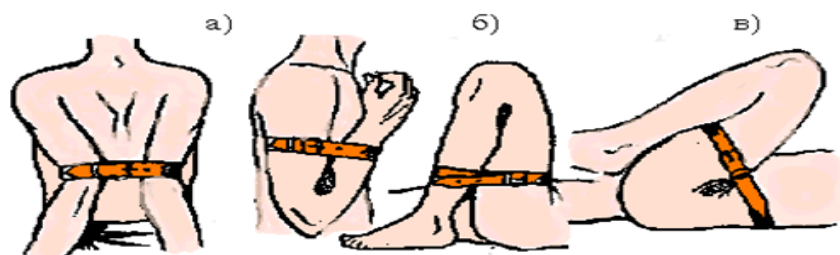
Подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине пальцами к плечевой кости



Бедренная артерия прижимается кулаком в области паховой складки.



Остановка кровотечений из сосудов конечностей при отсутствии переломов возможна при форсированном их сгибании.



ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫМ СГИБАНИЕМ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ РАНЕНИИ СОСУДОВ
а - у корня плеча; б - голени и стопы; в - бедра



Чаще этот способ применяется для остановки кровотечений из сосудов руки. Его рационально применять при интенсивном кровотечении из ран, расположенных у основания конечностей. Максимальное сгибание конечности производят в суставе выше раны и фиксируют конечность бинтами в таком положении.

Так, при остановке кровотечений из ран предплечья и кисти на сгибательную поверхность локтевого сустава укладывают ватно-марлевый пелот (его можно заменить небольшим валиком из материи), затем руку максимально сгибают в локте, притягивая с помощью бинта или ремня предплечье к плечу до исчезновения пульса на запястье, прекращения истечения крови из раны. В таком положении руку фиксируют бинтом (ремнем).

При кровотечениях из верхней части плеча и подключичной области, которое может быть смертельным, заводят оба плеча за спину со сгибанием в локтевых суставах, после чего их связывают с помощью бинта (ремня и т.п.). В этом случае сдавливаются артерии с обеих сторон.

Правила наложения жгута

НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕЙ МЕРОЙ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ!

Показания к наложению жгута:

1. Если нельзя остановить кровотечение другими способами.
2. При синдроме длительного сдавления (более часа) при извлечении пострадавшей конечности.
3. При нежизнеспособности конечности (полная или частичная ампутация).



Как наложить жгут:

1. Перед наложением жгута на голое тело следует проложить тканевую или бинтовую подкладку для уменьшения риска дополнительного травмирования кожи на конечности.



2. После этого необходимо завести жгут под конечность, растянуть его и наложить первые растянутые 2 тура жгута.



3. Далее следует накладывать жгут так, чтобы каждый последующий тур наполовину прикрывал предыдущий. Растягивать при этом жгут не надо. После наложения жгута он фиксируется соответствующим образом, под ним закрепляется записка с указанием времени наложения.

Правила наложения жгута:

- Нельзя накладывать жгут на голое тело.
- Кожа должна быть без складок (расправлена).
- Обернуть участок конечности марлей или полотенцем.
- Завести жгут за конечность. Направление туров снизу-вверх, они не должны пересекаться.
- Туго накладывают 2 первых витка, следующие - без натяжения.
- Критерий правильности - остановка кровотечения.
- После наложения жгута конечность следует обездвижить (иммобилизировать) доступными способами.
- Оставить записку с указанием даты, времени наложения жгута и фамилии наложившего. Если пострадавший без сознания, написать «ЖГУТ» и время его наложения на лбу.
- Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, следует сделать следующее
- Каждые 30 минут жгут ослаблять, на 3-5 минут, для восстановления кровообращения. На время расслабления жгута рану прижать для остановки кровотечения, а после повторного наложения жгута рану разбинтовать и наложить новую повязку.
- Общее время наложения жгута - не более 1 часа.
- Не закрывать жгут одеялами, и т.д.

Внутренние кровотечения

Виды внутренних кровотечений:

открытые - кровь из полых органов вытекает наружу.

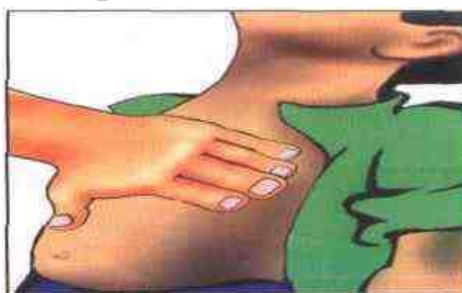
закрытые - скрытые кровотечения из повреждённых внутренних органов в полости организма. Возникает при повреждении внутренних органов при проникающих ранениях или разрывах внутренних органов при тупых травмах. Значительная кровопотеря возникает при переломах крупных костей, когда в места переломов изливается большие объёмы крови.

Признаки и симптомы:

1. Отёк, напряжение, болезненность и изменение цвета кожи над местом повреждения.
2. Учащение дыхания и пульса.
3. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь.
4. Тошнота и рвота.
5. Жажда.
6. Изменение уровня сознания.
7. При открытых внутренних кровотечениях -выделение рвоты с кровью, при кашле, из прямой кишки и т.д.
8. При переломах костей - отёк, напряжение, боль и изменение цвета кожи над местом повреждения.
9. При массивных внутренних кровотечениях - в результате разрывов или ранений внутренних органов признаки шока.

Проникающие ранения груди.

как накладывать повязки на раны



Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха.

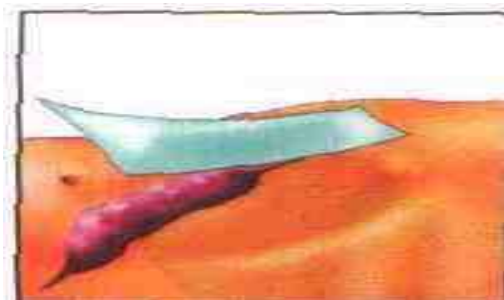
Недопустимо извлекать из раны инородные тела и предметы на месте происшествия.



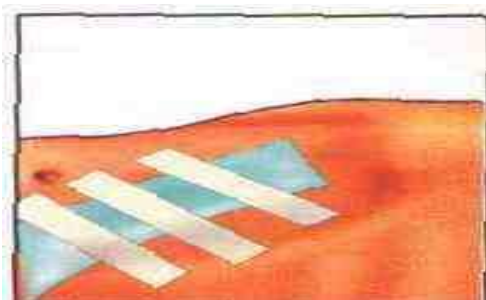
Наложить герметичную повязку или заклеить лейкопластырем.

Проникающие ранения живота

как накладывать повязки на раны



Прикрыть содержимое раны чистой



Прикрепить салфетку полностью прикрывающую края раны, пластырем.



Приподнять ноги и расстегнуть поясной.

Ожидание помощи и транспортировка – только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами.



Запрещается:

Вправлять выпавшие органы;

Давать пить.

Внутренние кровотечения

Виды внутренних кровотечений:

Открытые - кровь из полых органов вытекает наружу.

Закрытые - скрытые кровотечения из повреждённых внутренних органов в полости организма. Возникает при повреждении внутренних органов при проникающих ранениях или разрывах внутренних органов при тупых травмах. Значительная кровопотеря возникает при переломах крупных костей, когда в места переломов изливается большие объёмы крови.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

1. Отёк, напряжение, болезненность и изменение цвета кожи над местом повреждения
2. Учащение дыхания и пульса
3. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь
4. Тошнота и рвота
5. Жажда
6. Изменение уровня сознания
7. При открытых внутренних кровотечениях -выделение рвоты с кровью, при кашле, из прямой кишки и т.д.
8. При переломах костей - отёк, напряжение, боль и изменение цвета кожи над местом повреждения
9. При массивных внутренних кровотечениях - в результате разрывов или ранений внутренних органов признаки шока.

ШОК

Это состояние, развивающееся в результате недостаточного обеспечения тканей организма богатой кислородом кровью, причиной которого являются:

1. Неспособность сердце обеспечить приток оксигенированной крови к тканям и органам
2. Необычно выраженное расширение сосудов
3. Потеря значительного объёма крови

Оказывающий первую помощь должен помнить о возможности развития шока у пострадавших с наиболее тяжелыми заболеваниями и повреждениями.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

1. Возбуждение и беспокойство, сменяющееся апатией и безразличием.
2. Изменение уровня сознания
3. Кожа бледная, холодная и влажная
4. Частое, поверхностное дыхание
5. Частый пульс слабого наполнения
6. Сильная жажда

Первая помощь при шоке

Оказывающий первую помощь должен:

1. Произвести общую начальную оценку всех пострадавших или пострадавшего (БСДДК)
2. Вызвать 03, при необходимости начать СЛР
3. Продолжать наблюдение за жизненно важными функциями организма.

В ожидании бригады скорой помощи:

1. Успокоить пострадавшего, обеспечить покой, а при необходимости согреть.
2. Предупредить дальнейшую потерю крови - если есть какое-либо кровотечение наружное -остановить его.
3. Уложить пострадавшего в удобное положение и обеспечить покой.
4. При проникающих ранениях или тупой травме живота с подозрением на внутреннее кровотечение уложить на спину с приподнятыми ногами.
5. Обеспечить согревание.
6. При подозрении на повреждение органов брюшной полости - не давать пить и есть.
7. Каждые 5 минут считать и записывать пульс.
8. Обеспечить первую помощь в отношении имеющихся повреждений

Первая помощь при термических поражениях (гипер- и гипотермические воздействия локальные и местные). Химические ожоги

Термические ожоги.

Ожог - повреждение тканей, возникшее от местного теплового, химического, электрического и радиационного воздействия. В зависимости от вида воздействия ожоги подразделяются на термические, химические, лучевые, электрические, световые и солнечные.

Термический ожог - ожог, вызванный воздействием источников тепла, например, пламени, горячей жидкости, раскаленных предметов, Термический ожог, вызванный воздействием горячей жидкости или пара, называют обвариванием.

Химический ожог - ожог, вызванный воздействием каких-либо химических веществ, например, кислот, щелочей.

Лучевой ожог - ожог, вызванный воздействием ионизирующего излучения,

Электрический ожог - ожог, вызванный прохождением через ткань электрического тока значительной силы и напряжения; характеризуется большой глубиной поражения.

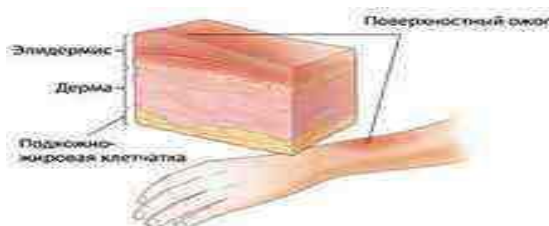
Световой ожог - термический ожог, вызванный воздействием интенсивного светового излучения, например, при ядерном взрыве.

Солнечный ожог - ожог кожи, вызванный воздействием солнечного излучения.

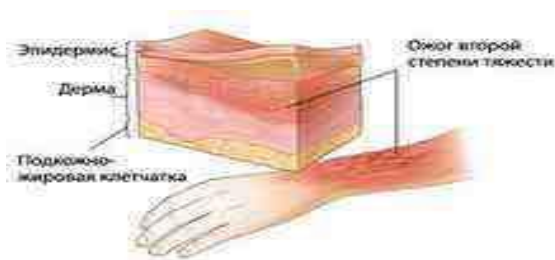
Ожоги относятся к наиболее часто встречающимся несчастным случаям, требующим оказания срочной помощи. 90-95% всех ожогов относятся к термическим.

В зависимости от глубины поражения кожи и подлежащих тканей ожоги делятся на 4-е степени: легкую (1-ая), средней тяжести (2-я), тяжелую (3-я) и крайне тяжелую (4-ю).

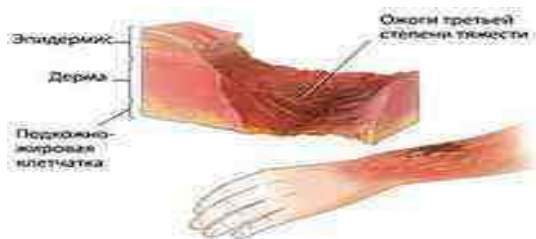
Ожог 1-ой степени характеризуется покраснением кожи, отеком, болью. Эти явления через 2-5 дней проходят, на месте ожога отмечается шелушение кожи.



Ожог 2-ой степени характеризуется резким покраснением кожи, образованием водянисто-серозных пузырей, жгучей болью. Если пузыри не прорываются (не нарушается целостность поверхности ожога) и не происходит инфицирования, то через 10-15 дней пораженные ткани восстанавливаются без образования рубцов, если пузыри срываются, ожоговая поверхность кожи загрязняется, заживление затягивается на более длительное время и на месте ожога могут образоваться рубцы.



Ожог 3-ей степени характеризуется омертвением всех слоев кожи. Поверхность ожога покрывается плотной серо-коричневой пленкой (струпом), омертвевшие ткани нагнаиваются и отторгаются, а на месте развивается рубцевание тканей, на что уходит значительное время.



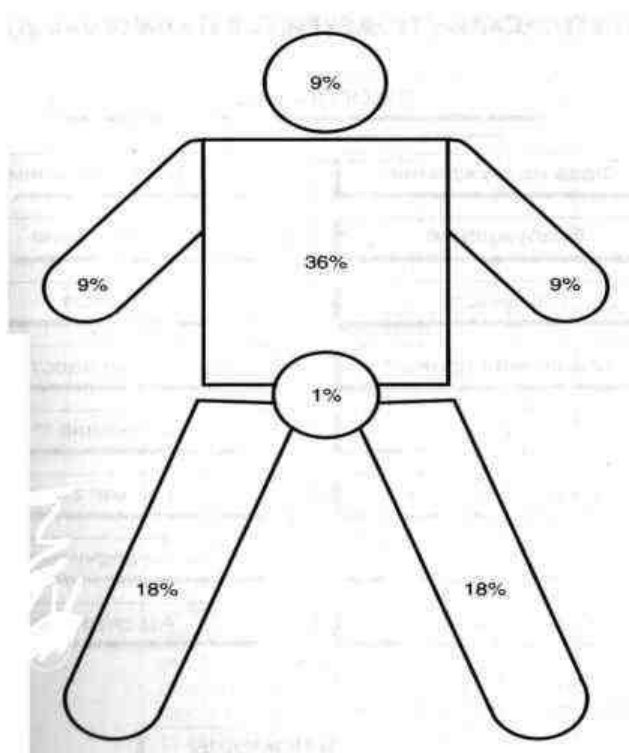
Ожог 4-ой степени возникает при воздействии на ткани очень высоких температур. Происходит обугливание кожи, подлежащих мягких тканей и даже костей. Характерно, что при ожогах 3-4 степени боль менее выражена, чем при ожогах 1-2 степени, что объясняется поражением при глубоких ожогах нервных окончаний, воспринимающих болевые ощущения

Правила определения площади ожога

Правило девятки

Правило ладони

При ожогах более 15% поверхности тела развивается **ожоговая болезнь** – тяжелое нарушение общего состояния, сопровождающееся обезвоживанием, шоком, интоксикацией, развитием инфекционных осложнений, недостаточностью жизненно-важных органов и систем. При этом ожоги более 40% поверхности тела считаются очень тяжелыми, а более 80 -90 % поверхности тела – часто несовместимыми с жизнью.



Первая помощь:

При обширных ожогах, вдыхании дыма, горячих газов - вызвать 03 и БСДДК.

При ожогах горячими предметами или кипятком удалить мокрую или сгоревшую одежду над ожоговой поверхностью. Удалить остатки сгоревшей одежды и стесняющие предметы (кольца, браслеты и т.д.) **но не отрывать прилипшие части!**

При ожогах пламенем, если горит одежда, заставить пострадавшего лечь и затушить огонь порошковым огнетушителем, водой или сбить огонь тяжёлой тканью/одеждой. Если это невозможно - уложить пострадавшего горящим боком вниз, чтобы придавить пламя. **Не давать пострадавшему кататься по земле!**

Не использовать маслосодержащие средства, лосьоны, антисептики!

Орошать обожжённую поверхность холодной водой не менее 10 минут, или пока боль не уменьшится. **Не вскрывать и не прокалывать пузыри!**

Вскрывшиеся пузыри и обожжённую поверхность закрыть сухой стерильной салфеткой, чистой тканью, и зафиксировать их без натяжения к здоровой коже.

Химические ожоги

Первая помощь

1. Контроль БСДДК, по возможности использовать перчатки и защитные очки
2. Сухие частицы химического вещества/порошок удалить рукой в перчатке, сухой салфеткой, тканью или щёткой.
3. Удалить загрязнённую одежду и носимые предметы.
4. Промыть затронутые участки кожи большим объёмом воды в течение не менее 30 минут, под проточной водой.
5. Покрасневшие участки кожи накрыть бинтом или чистой тканью.

Не применять нейтрализующие химические вещества!

Тепловые повреждения (перегревание).

Чаще всего встречаются относительно легко устранимые виды тепловых повреждений - тепловые судороги, тепловое изнурение, и тепловой обморок (солнечный удар), но иногда перегревание организма может привести к смертельно опасному тепловому удару.

Виды тепловых повреждений:

- Тепловые судороги
- Тепловое изнурение
- Тепловой обморок
- Тепловой удар

Способствующие факторы

- Высокая температура окружающей среды (снижается потеря тепла за счёт излучения)
- Высокая влажность окружающей среды (снижается потеря тепла за счёт испарения)
- Тяжелая физическая работа или упражнения (за 1 час работы с потом может выделиться до 1 литра)
- Возраст (дети и старики)
- Сопутствующие заболевания

- Алкогольное/наркотическое опьянение, отравления.

Признаки теплового изнурения и судорог:

Признаки связаны с обезвоживанием и потерей минеральных солей из-за обильного потоотделения: жар, головная боль, головокружение, резкая слабость, тошнота, жажда, судороги в мышцах конечностей. Учащение пульса и дыхания, Кожа бледная или покрасневшая, влажная или сухая.

Признаки теплового обморока (солнечного удара)

Кратковременная потеря сознания без повышения температуры тела.

Признаки теплового удара

Неадекватное поведение, шаткая походка, головная боль, нарушение зрения, потеря сознания длительное.

Потоотделение прекращается, горячая сухая кожа, высокая температура тела.

Частый пульс. Наблюдаются общие судороги.

Потеря сознания в сочетании с повышением температуры тела являются признаками теплового удара.

Первая помощь:

1. Вызвать «103» или «03», «112» и контроль БСДДК.
2. При необходимости начать СЛР.
3. При тепловом обмороке, если вы видите, что больной падает, поддержать его, чтобы смягчить падение, уложить его на спину, расстегнуть стягивающую одежду, поднять ноги выше его головы, обрызгать лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь.
4. Переместить пострадавшего в прохладное помещение и снять с него всю одежду.
5. Обернуть пострадавшего влажной простынёй и смачивать её холодной водой по мере нагревания.
6. Наложить на шею, паховую и подмышечную области пакеты со льдом (через ткань).

7. Не допускать физических усилий и его дальнейшего пребывания на жаре.
8. Дать обильное питьё прохладной подсоленной минеральной воды.
9. Наладить обдувание с помощью вентилятора.
10. При нарушении сознания не давать ничего через рот и уложить больного в восстановительное положение, если нет подозрения на травму позвоночника.

Воздействия низких температур (обморожение, общее переохлаждение, гипотермия).

Гипотермия - это состояние, развивающееся в результате общего воздействия низких температур, при котором происходит снижение t тела ниже 35 градусов. Причиной возникновения обморожений является воздействие низких температур, а при определенных условиях (мокрая и тесная обувь, неподвижное положение на холодном воздухе, алкогольное опьянение, и кровопотеря) обморожение может быть и при температуре выше 0 °С. Чаще подвергаются обморожению уши, нос, кисти (пальцы) рук, стопы ног. При отморожении вначале ощущаются чувство холода и жжения, затем появляется онемение. Кожа становится бледной, чувствительность утрачивается.

В дальнейшем действие холода не ощущается. Установить степень обморожения можно только после отогревания пострадавшего, иногда через несколько дней.

Способствующие факторы

- Низкая t° С окружающей среды.
- Возраст (дети и старики).
- Сопутствующие заболевания.
- Алкогольное или наркотическое опьянение.

Признаки гипотермии

В зависимости от состояния сознания различают 3 степени гипотермии:

Оглушения – пребывание в низкотемпературной среде, кожа холодная, чувствительность снижена, затруднённая речь, головокружение, озноб, снижение АД, дыхание 10 – 12 в минуту, пульс 40 – 50 в минуту, t тела около 35° С.

Ступор – добавляется скованность мышц и суставов, нарушение сознания в виде ступора, дыхание до 10 в минуту, пульс до 40 в минуту, t тела 32-35° С.

Кома – пульс редкий, до 10 – 12 в минуту, дыхание до 2 – 3 в минуту, t тела ниже 30 – 32° С, расширение зрачков, кома.

Различают 4 степени отморожения.

Обморожение 1-ой степени - характеризуется побледнением кожи, незначительной отечностью и понижением ее чувствительности, т.е. небольшими обратимыми расстройствами кровообращения. При согревании пострадавшего кровоснабжение восстанавливается, кожа приобретает первоначальный цвет, отечность постепенно исчезает. Позже может возникнуть шелушение и зуд кожи, длительно сохраняться повышенная чувствительность кожи к холоду.

Обморожение 2-ой степени - характеризуется более глубоким поражением кожи. При согревании бледные кожные покровы становятся багрово-синими, быстро развивающийся отек распространяется за пределы отморожения, образуются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, появляются сильные боли. У пострадавшего отмечается озноб, повышение температуры, нарушаются сон и аппетит. Поврежденные поверхностные слои кожи отторгаются.

Заживление при отсутствии осложнений (нагноения) происходит в течение 15-30 дней. Кожа раневой поверхности остается синюшной, ее чувствительность снижена.

Обморожение 3-ей степени - характеризуется поражением всех слоев кожи и подлежащих мягких тканей на различную глубину. В первые дни на коже появляются пузыри, наполненные темно-бурой жидкостью, вокруг которых развивается воспаление, образуется резко выраженный отечный вал. После 3-5 дней выявляется глубокое повреждение ткани (влажная гангрена).

Пострадавшего беспокоят сильные боли, температура повышается до 38-39 ° С, потрясающий озноб сменяется потом, общее состояние значительно ухудшается.

Обморожение 4-ой степени - характеризуется поражением кожи, мягких тканей и костей. При этом развиваются необратимые явления. Кожа покрывается пузырями с жидкостью черного цвета.

Через 10-17 дней вокруг поврежденной зоны определяется линия отморожения, которая чернеет, высыхает и через 1,5-2 месяца отторгается. Рана заживает очень медленно. Общее состояние пострадавшего тяжелое, повышение температуры чередуется с ознобом, отмечаются изменения во внутренних органах, которые нарушают их нормальную работу



"Железное" обморожение

В практике встречаются и холодовые травмы, возникающие при соприкосновении теплой кожи с холодным металлическим предметом. Стоит любопытному малышу схватиться голый рукой за какую-нибудь железку или, того хуже, лизнуть ее языком, как он намертво к ней прилипнет.

Освободиться от оков можно, только отодрав их вместе с кожей. Картина прямо-таки душераздирающая: ребенок визжит от боли, а его окровавленные руки или рот приводят родителей в шок. К счастью, "железная" рана редко бывает глубокой, но все равно ее надо срочно продезинфицировать.

- Сначала промойте ее теплой водой, а затем перекисью водорода. Выделяющиеся пузырьки кислорода удалят попавшую внутрь грязь.
- После этого попытайтесь остановить кровотечение. Хорошо помогает приложенная к ране гемостатическая губка, но можно обойтись и сложенным в несколько раз стерильным бинтом, который нужно как следует прижать и держать до полной остановки кровотечения.
- Но если рана очень большая, надо срочно обращаться к врачу.

- Бывает, что прилипший ребенок не рискует сам оторваться от коварной железки, а громко зовет на помощь. Ваши правильные действия помогут избежать глубоких ран. Вместо того, чтобы отрывать кожу "с мясом", просто полейте прилипшее место теплой водой (но не слишком горячей!). Согревшись, металл обязательно отпустит своего незадачливого пленника.

Острые отравления, их виды. Первая помощь при различных видах отравлений

Отравляющие вещества - это вещества, которые при попадании в организм вызывают повреждение его структур или нарушают его функции. Действие некоторых из них проявляется сразу, других - нет. Скорость развития симптомов зависит также от дозы отравляющего вещества.

Симптомы отравлений разнообразны и многочисленны. Наиболее вероятными из них могут быть:

- Бледные, холодные и влажные кожные покровы, цианоз.
- Частый, слабого наполнения пульс.
- Тошнота и рвота.
- Головная боль, звон в ушах, сонливость, которая может перейти в утрату сознания.
- Боли в области рта, по ходу пищевода, в животе, характерный запах изо рта, химические ожоги вокруг рта.
- Нарушение зрения, судороги.
- Нарушение дыхания.

Пути проникновения токсических веществ в организм:

Через желудочно-кишечный тракт.

Через кожу и слизистые оболочки.

Через дыхательные пути.

Посредством инъекций.

Отравления газообразными веществами

Все газообразные отравляющие вещества делятся на:

Раздражающие — вызывают ожоги кожи и слизистых оболочек дыхательных путей (хлор, аммиак, формальдегид, двуокись серы, озон, фосген, двуокись азота).

Удушающие — замещают кислород во вдыхаемом воздухе и вызывают недостаток кислорода в организме, тяжесть которого зависит от концентрации газа и продолжительности его вдыхания (аргон, неон, гелий, водород, метан, этан, ацетилен, пропан, бутан, природный газ и двуокись углерода).

Токсические — вызывают истинное отравление при вдыхании (сероводород, синильная кислота, окись углерода, фосфорорганические соединения).

Хлор

Газ жёлто — зелёного цвета со своеобразным «колющим» запахом, легко сжижающийся в жёлто — зелёную жидкость. При испарении соединяется с водяными парами с образованием белого тумана.

Признаки воздействия:

Поражение органов дыхания с развитием отёка лёгких. Появляется кашель, удушье, головокружение, головная боль, слабость. Через несколько часов появляется чувство нехватки воздуха, одышка, кашель с большим количеством мокроты, цианоз.

Аммиак

Бесцветный газ с характерным острым запахом, хорошо растворимый в воде. 10% раствор называют нашатырным спиртом.

Признаки отравления:

Слезотечение, слюнотечение, жжение в глазах, кашель с пенистой мокротой, удушье, цианоз. При приёме внутрь может присоединиться рвота с кровью, боли по ходу пищевода. При попадании в глаза боль и отёк конъюнктивы. При попадании на кожу признаки ожога.

Сернистый ангидрид

Бесцветный газ с острым запахом горящей серы, растворимый в воде.

Признаки отравления:

Жжение в глазах, горле, слезотечение, рвота, удушье, кашель, сердцебиение. При концентрации 26 мг/м³ в кубе вызывает раздражение увлажнённой кожи.

Первая помощь:

1. Обеспечить личную безопасность, использовать средства индивидуальной защиты.
2. Убедиться в проходимости дыхательных путей и адекватности дыхания.
3. Надеть противогаз, вынести из загазованной зоны.
4. Убедиться, что вызвана скорая медицинская помощь.
5. При остановке дыхания искусственное дыхание.
6. При остановке кровообращения СЛР.
7. При наличии дать кислород.
8. Глаза и горло промыть 2% содой.
9. Если пострадавший в сознании, при приёме аммиака внутрь, промыть желудок. При попадании в глаза – промыть их водой и наложить повязку. При попадании на кожу – обильно её промыть, сняв загрязнённую одежду.

Монооксид углерода (угарный газ)

Оксид углерода – прозрачный, без цвета и запаха газ, образующаяся при неполном сгорании углеродного топлива. Внешними источниками его являются двигатели внутреннего сгорания, неисправные печи, отопительные системы, дым при пожаре, двигатели на газе.

Симптомы зависят от количества заблокированного гемоглобина в крови (карбоксигемоглобина).

При концентрации 20 – 40%:

Гриппоподобный синдром – головокружение, головная боль, слабость, спутанность сознания, тошнота, рвота.

При концентрации 40 – 60%:

Одышка, частый пульс, неустойчивая походка, могут быть судороги и потеря сознания.

При отравлении нет синюшности и цианоза!

Первая помощь:

Антидотом является кислород.

Вызвать «103» или «03», «112» и БСДК.

При остановке дыхания и кровообращения СЛР.

Сероводород

Бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц. Хорошо растворим в воде, водные растворы являются слабой кислотой, и при попадании на кожу вызывают её раздражение.

Признаки воздействия низких концентраций:

- Головная боль.
- Головокружение.
- Усталость, астения.
- Симптомы бронхита и конъюнктивита - кашель, слезотечение, покраснение конъюнктивы глаз.
- Серо-зелёное окрашивание дёсен.

Первая помощь:

- 1 Вызвать «103» или «03», «112» и БСДДК
- 2 Прекратить воздействие сероводорода

Признаки воздействия высоких концентраций:

- Преимущественное поражение нервной системы и лёгких.
- Головокружение, тошнота, рвота, возбуждение или спутанность сознания вплоть до утраты.
- Дрожь в теле.
- Кашель, одышка, цианоз, кровохарканье и отёк лёгких.

Первая помощь:

1. Вызвать «103» или «03», «112» и БСДДК и использовать средства индивидуальной защиты.
2. Надеть на пострадавшего противогаз и/или немедленно вывести из загазованной зоны.
3. При наличии дать кислород.
4. При остановке кровообращения начать СЛР.
5. При отсутствии сознания придать восстановительное положение.
6. При наличии сознания и антидота (**амилнитрита**) дать вдыхать, разбив ампулу.

Признаки воздействия очень высоких концентраций:

Быстро развивающееся поражение ствола головного мозга, которое вызывает судороги, и остановку кровообращения. При концентрации 800-1000 мг/м в кубе смерть наступает почти мгновенно.

Метанол

Метанол растворим в спиртах и ряде других органических растворителей. С водой смешивается во всех отношениях. Легко воспламеняется. Обладает цветом, запахом и вкусом сходными с таковыми этилового (винного) спирта. Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г. Действие паров его выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу.

Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5мг/м

Отравление может наступить при вдыхании паров, всасывании через кожу и употреблении внутрь.

Острое отравление наступает обычно при приеме метанола внутрь (высшая токсическая доза 100 мл)

Через 8-12 ч появляются головная боль, головокружение, боли в животе, тошнота и рвота, общая слабость, мелькание в глазах, двигательное возбуждение, потеря зрения.

Ощущение опьянения обычно мало выражено. При осмотре отмечается цианоз кожи и слизистых.

Прогрессирующее снижение зрения до полной слепоты.

В тяжелых случаях отмечается цианоз губ, конечностей, пульс учащается, сознание спутано, возбужденное состояние. Периодически появляются судороги в конечностях

Первая помощь:

1. Оценка БСДДК, вызов «103» или «03», «112»
2. При приеме метанола внутрь обязательно тщательное промывание желудка для чего следует выпить 500—750 мл воды комнатной температуры, затем вызвать рвоту, нажав пальцем или ложкой на корень языка. Такие манипуляции следует проводить до тех пор, пока из желудка не будет выходить чистая вода (в общей сложности следует пропустить через желудок около 10 литров воды).
3. После этого необходимо принять 10—20 таблеток активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.

4. Как эффективное противоядие после промывания дают выпить 200 мл 30-40% раствора этилового спирта в два приема. Этиловый спирт нарушает метаболизм метанола посредством связывания определенных ферментных систем организма и своим воздействием может спасти потерпевшего от смертельного исхода.

5. При отравлении парами метанола - дать пострадавшему принять внутрь 200 мл 30-40% раствора этилового спирта

6. Назначают обильное питье щелочных вод (до 3-4 л 3% раствора гидрокарбоната натрия, боржом).

Меркаптаны

Применяется в качестве одорантов - веществ, добавляемых к газу для придания ему запаха. Применяется чаще этилмеркаптан.

Признаки отравления:

В низкой концентрации вызывает диарею и рвоту.

В высоких – утрата сознания судороги и цианоз.

Первая помощь:

1. При отравлении лёгкой степени – прекратить воздействие.
2. При тяжёлом отравлении - Вызвать «103» или «03», «112» и БСДДК и использовать средства индивидуальной защиты.
3. Надеть на пострадавшего противогаз и/или немедленно вывести из загазованной зоны.
4. При наличии дать кислород.
5. При остановке кровообращения начать СЛР.
6. При отсутствии сознания придать восстановительное положение.

Газоконденсат

Это жидкие углеводороды, встречающиеся в соединении с природным газом. Симптомы зависят от дозы, концентрации, времени воздействия и разновидности углеводородов в его составе.

Признаки отравления:

Со стороны лёгких наблюдается удушье, одышка, чувство нехватки воздуха, отёк легких.

Со стороны желудочно-кишечного тракта – ожог слизистых, тошнота, рвота, боли в животе, диарея.

Со стороны ЦНС – головная боль, атаксия. Головокружение, спутанность сознания, кома, судороги.

Со стороны ССС – частый пульс, снижение АД.

Со стороны кожи и глаз – раздражение, ожоги.

Первая помощь:

Зависит от симптомов.

1. Вызвать «103» или «03», «112» и контроль БСДДК.
2. При остановке кровообращения начать СЛР.
3. При отсутствии сознания придать восстановительное положение

Поражение электрическим током. Методы подхода, освобождения от фактора воздействия. Эвакуация из очага поражения, правила собственной безопасности. Первая помощь.

Поражение электрическим током возникает при соприкосновении с электрической цепью, в которой присутствуют источники напряжения и/или источники тока, способные вызвать протекание тока по попавшей под напряжение части тела. Обычно чувствительным для человека является пропускание тока силой более 1мА. Кроме того, на установках высокого напряжения возможен удар электрическим током без прикосновения к токоведущим элементам, в результате утечки тока или пробоя воздушного промежутка.

Сила поражения зависит от мощности разряда, от времени воздействия, от характера тока (постоянный или переменный), от состояния человека—влажности рук и т. п., а также от места соприкосновения и пути прохождения тока по организму

Последствия

1. Из-за высокого электрического сопротивления человеческих тканей происходит довольно быстрое их нагревание, что может вызывать ожоги.
2. Даже сравнительно малые напряжения, порядка 110—230 В, при кратковременном контакте с грудной клеткой могут вызывать сбой в работе сердечной мышцы (60 мА для переменного тока, 300—500 мА для постоянного)..
3. Удар током может вызвать сбой в работе нервной системы, например, беспорядочные сокращения мышц. Повторяющиеся удары могут вызвать невропатию. Острая электротравма может стать причиной нарастающей асистолии.

4. При поражении головы электрическим током возможна потеря сознания.

5. При достаточно высоких напряжениях и силе тока могут возникать так называемые электрические дуги, наносящие сильные термические ожоги. Электрическая дуга также создает сильное световое излучение (ярче, чем Солнце), поэтому, например, сварщики используют специальные маски (очки) с темным стеклом (светофильтром), чтобы защитить глаза, и специальные перчатки и одежду, чтобы обезопасить себя от удара током

6. Воздействие тока выше 100 вольт опасно, а свыше 500 - почти всегда смертельно.

7. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц. Вследствие этого пальцы, если пострадавший держит провод руками, могут так сильно сжиматься, что высвободить провод из его рук становится невозможным.

При этом необходимо учитывать следующее:

а) в случае нахождения пострадавшего на высоте отключение установки и освобождение пострадавшего от электрического тока могут привести к падению пострадавшего с высоты;

В этом случае должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность падения пострадавшего;

б) при отключении установки может одновременно отключиться также и электрическое освещение, в связи с чем, следует обеспечить освещение от другого источника (фонарь, факел, свечи, аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.) не задерживая, однако, отключения установки и оказания помощи пострадавшему.

8. Если отключение установки не может быть произведено достаточно быстро, необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или привода следует воспользоваться сухой одеждой, канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Использование для этих целей металлических или мокрых предметов не допускается.



Для отделения пострадавшего от токоведущих частей можно также взяться за его одежду (если она сухая и отстает от тела пострадавшего), например, за полы пиджака или пальто, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела, не прикрытым одеждой. Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока.

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать себе руки шарфом, надеть на руки суконную фуражку, опустить на руку рукав пиджака или пальто, использовать прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю.

Можно также изолировать себя, встав на сухую доску или какую-либо другую не проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и т.п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать по возможности одной рукой.

Способы и методы оказания помощи:

- а) быстрое отключение электрического тока,
- б) особое внимание если человек находится на высоте,
- в) аварийный свет необходим,
- г) до 1000В - оттаскивать за одежду одной рукой,
- д) выше 1000В - действовать штангой, отключение, набросом заземленного провода.



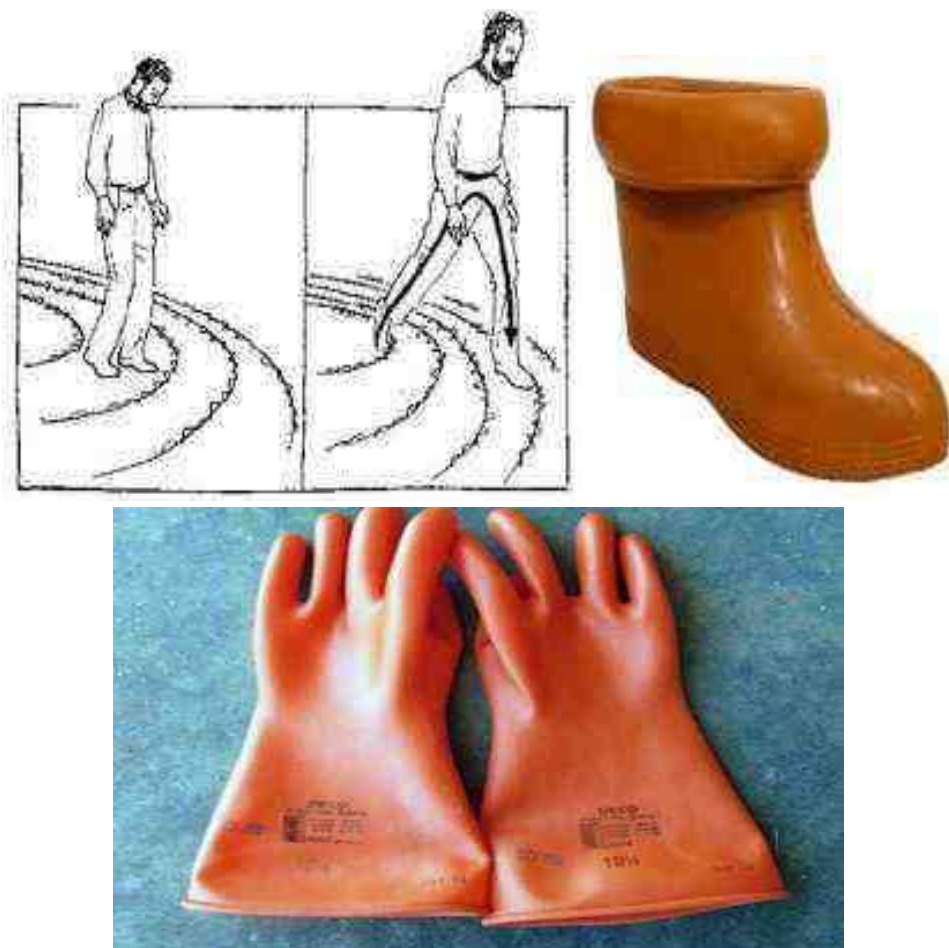
Признаки и симптомы:

- Возможен коллапс с потерей сознания
- Возможны судороги
- Затруднение дыхания вплоть до его остановки
- Пульс слабого наполнения или отсутствие его, нарушения ритма сердца
- Симптомы внезапной остановки сердца (внезапная резкая бледность, потеря сознания, исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или появление единичных, судорожных вдохов).
- Наличие электрических ожогов вплоть до обугливания или «меток» - округлых пятен до 5-6 см., тёмных внутри и синеватых снаружи.
- Возможны переломы конечностей.

В радиусе 8 метров от места касания земли электропроводом можно попасть под «шаговое напряжение».

передвигаться в зоне «шагового напряжения» следует в диэлектрических ботах или галошах, либо «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги

нельзя: отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги; приближаться бегом к лежащему проводу.



Правила перемещения, эвакуации пострадавшего, ухода за пострадавшим или больным до приезда бригады скорой помощи. Аптечка первой помощи.

Перемещение, изменение положения и транспортировка пострадавшего.

Пострадавшего с тяжёлой скелетной травмой, при тяжёлом общем состоянии, при подозрении на повреждение внутренних органов, а также пострадавших без сознания можно перемещать (**экстренное перемещение**) только в следующих случаях:

- Если без перемещения создаётся непосредственная угроза жизни пострадавшего.
- Если мероприятия по оказанию первой помощи не могут быть выполнены в том положении, в котором он находится.
- Если нет непосредственной угрозы жизни, то перемещение должно выполняться спец. бригадой.
- Если пострадавший в сознании, необходимо ему объяснить, что вы собираетесь делать.

Экстренное перемещение пострадавшего.

1. Должна производиться спокойно, без рывков, направление тяги должна совпадать с продольной осью тела.
2. При наличии одного спасателя можно воспользоваться следующими методами:
3. Волоком за одежду возле шеи и плеч.
4. Волоком за одеяло.
5. Волоком, просунув руки подмышки сзади, ухватившись за его предплечья.
6. На короткие расстояния и на ровной поверхности волоком за ноги.
7. При наличии помощников - первый берёт за плечи, второй за таз и руки, третий за ноги.

Переноска пострадавшего в одиночку

Переноска пострадавшего волоком



Переноска пострадавшего на плече Для этого пострадавшего надо взять за руку, взвалить на свое плечо и переместить его в нужное место.



Для **переноса с поддержкой** следует расположить руку пострадавшего на своей шее и, придерживая пострадавшего за руку и талию помочь ему переместиться в нужном направлении



Для **переноски пострадавшего на спине** следует присесть спиной к нему дождаться, когда он поместится на спине, распрямится и придержать пострадавшего под колени



Для **переноски пострадавшего на руках** необходимо встать на колени, усадить пострадавшего на свое колено и поднять пострадавшего на руках

Переноска пострадавшего вдвоем



Для **переноски пострадавшего на замке из рук** следует зять руки в замок присесть, расположить пострадавшего на замке из рук, и переместить его в нужном направлении

Для **переноски ослабленных больных** следует взять 3 руки в замок, присесть, расположить и переместить пострадавшего. При этом свободная рука одного из участников оказания помощи держится за плечо другого, образуя импровизированную «спинку», на которую может опираться пострадавший

Переноска пострадавшего за руки и ноги



Переноска пострадавшего несколькими участниками

Переноска пострадавшего с подозрением на травму позвоночника осуществляется несколькими участниками. Один из них располагается у головы пострадавшего и фиксирует шею и голову пострадавшего своими предплечьями. Второй участник фиксирует туловище и руки пострадавшего, третий участник фиксирует ноги пострадавшего.



По команде участника, располагающегося у головы пострадавшего, участники поднимают пострадавшего так, чтобы сохранить положение его тела стабильным и неподвижным.



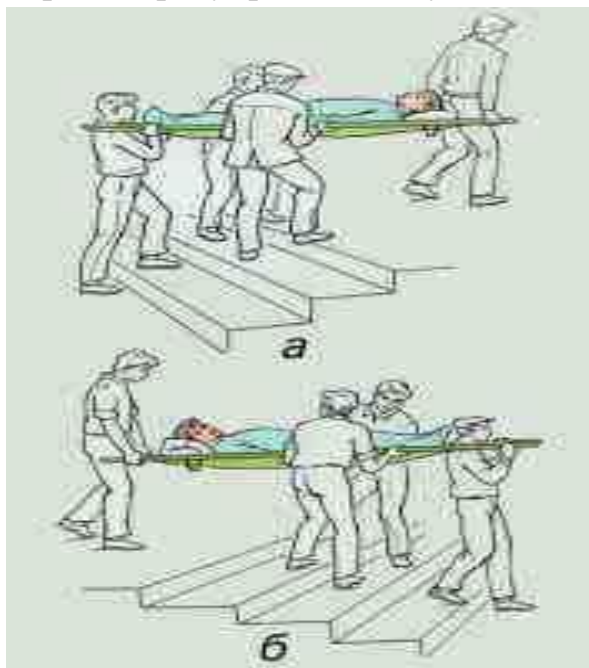
Пострадавший с самостоятельным дыханием, но без сознания, не имеющий травм, укладывается в восстановительное положение.

Положение пострадавшего с травмами не должно меняться до прибытия скорой. Исключение составляет при рвоте поворот на бок.

Если пострадавший жалуется на сильные боли, дискомфорт, затруднение дыхания, а так же при рвоте и тошноте ему следует принять удобное для него положение

Правила транспортировки пострадавшего на носилках.

1. При транспортировке вверх по лестнице или при помещении в скорую, пострадавшего несут головой вперёд.
2. При транспортировке вниз по лестнице и при извлечении из ОЗ, несут вперёд ногами.
3. Идущий впереди, предупреждает идущих сзади о препятствиях.



Переноска на импровизированных носилках



Придание устойчивого бокового положения



Перед началом придания этого положения следует положить пострадавшего ровно, снять очки, если имеются, после этого поднять ближнюю руку пострадавшего и положить ее перпендикулярно туловищу, затем взять дальнюю руку пострадавшего и приложить ее к щеке пострадавшего тыльной стороной при этом следует продолжать ее удерживать.



Далее надо взять дальнюю ногу пострадавшего под коленку и поставить ее на стопу. Затем, надавливая на колено согнутой ноги, надо повернуть пострадавшего набок, притянуть ногу к животу и слегка запрокинуть голову.



В этом положении пострадавший должен дожидаться приезда скорой медицинской помощи

Устойчивое боковое положение.



Положение на спине с приподнятыми ногами



Положение на спине с валиком под разведенными и согнутыми в коленях ногами



Полусидячее положение



Положение при подозрении на травму позвоночника (пострадавший в сознании).



Использование спасательного одеяла



Приказ Минздрава России от 24.05.2024 №262н

«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам»

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам

№ п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество (не менее)
1	182450	Маска хирургическая, одноразового использования	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
	367580	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования		
2	122540	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
	122560	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные		
	139350	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные		
	139360	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные		
	185830	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные		
	185850	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные		
	205280	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные		
	205290	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные		
	298450	Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные		
	320790	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные		
	321530	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные		

№ п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество (не менее)
	349230	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные		
	351490	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные		
3.	327410	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот- Устройство-Рот"	2 шт.
	351540	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации		
4.	210370	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования	Жгут кровоостанавлив ающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
	210380	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования		
5.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный		
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования		
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования		
6.	150130	Рулон марлевый тканый, нестерильный	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	4 шт.
	150140	Рулон марлевый тканый, стерильный		
	279290	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования		
	326320	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования		
7	223580	Салфетка марлевая тканая, стерильная	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10	2 уп.
	302910	Салфетка нетканая		
8.	136010	Лейкопластырь кожный стандартный	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
	122900	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный		
	141730	Лейкопластырь кожный		

№ п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество (не менее)
	269230	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый		
9.	142270	Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	10 шт.
10	142270	Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	2 шт.
11	293880	Одеяло спасательное	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	2 шт.
12	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы для разрезания повязок	1 шт.
	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования		

Аптечка комплектуется следующими изделиями:

№ п/п	Наименование	Требуемое количество (не менее)
1.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий	1 шт.
2.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
3.	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.
4.	Футляр или сумка	1 шт.

Ведущий специалист по охране труда



А.В. Самохвалов

Согласовано:

Заместитель начальника ООТиПБ



А.В. Донских